

10%	(א) מעל 5 שנים לאחר ההשתלה	(10) השתלת תאי אב עצמיים
30%	(ב) בין שנה ל-5 שנים לאחר ההשתלה	
100%	(ג) בשנה הראשונה לאחר ההשתלה	
10%	(א) מעל 5 שנים לאחר ההשתלה מתורם א-תסמיני	(11) השתלת תאי אב מתורם
30%	(ב) מעל 5 שנים לאחר ההשתלה עם מחלה כרונית של שתל נגד מאחסן (GVHD)	
50%	(ג) בין שנה ל-5 שנים לאחר השתלה	
100%	(ד) בשנה הראשונה לאחר השתלה או עם מחלת שתל נגד מאחסן בצורה קשה	
	לעניין פרטי משנה (10) ו-(11), במקרים של השתלות תאי אב לא תיקבע נכות נפרדת בעד המחלה, שבשלה נזקקה ההשתלה, נוסף על הנכות בעד ההשתלה, אלא אם כן יש הישנות של המחלה;	
10%	(א) בתום התקופה האמורה בסעיף (ב), בהפוגה מלאה	(12) לימפומה מדרגת ממאירות גבוהה
30%	(ב) בתום התקופה האמורה בסעיף (ג) ולמשך שנה	
50%	(ג) בתום השנה הראשונה שלאחר האבחנה או ממועד סיום הטיפול הייעודי, לפי המאוחר, למשך שנה	
100%	(ד) במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או בתקופת הטיפול הייעודי במחלה	
	מיאלומה נפוצה	(13)
10%	(א) בתום התקופה האמורה בסעיף (ב) ובהפוגה מלאה -	
50%	(I) בלא צורך בטיפול	
100%	(II) עם טיפול מיצוק או עם טיפול אחזקה	
	(ב) במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או בתקופת הטיפול הייעודי במחלה, לפי המאוחר	
	לימפומה מדרגת ממאירות נמוכה	(14)
10%	(א) בתום התקופה האמורה בסעיף (ב), בהפוגה מלאה	
30%	(ב) בתום התקופה האמורה בסעיף (ג) ולמשך שנה	
50%	(ג) בתום השנה הראשונה שלאחר האבחנה או ממועד סיום הטיפול הייעודי, לפי המאוחר, למשך שנה	
100%	(ד) במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או בתקופת הטיפול הייעודי במחלה	
	לאוקמיה מיאלוציטית כרונית (CML)	(15)
10%	(א) בהפוגה ציטוגנטית מלאה	
30%	(ב) בהפוגה המטולוגית בלא הפוגה ציטוגנטית	
50%	(ג) במהלך השנה הראשונה מהאבחנה או בזמן הטיפול הייעודי במחלה שנשנתה או במחלה עמידה	
100%	(ד) בהתמרה ללאוקמיה חריפה	
	לאוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL)	(16)
10%	(א) בלא צורך בטיפול תרופתי	
30%	(ב) בתום התקופה האמורה בסעיף (ג) ובמהלך קבלת טיפול פומי	
50%	(ג) בתום התקופה האמורה בסעיף (ד) ולמשך שנה	
100%	(ד) במהלך השנה הראשונה מתחילת טיפול ייעודי	
	המופיליה מסוג A, B ו-C וחסר בגורמי קרישה אחרים	(17)
0%	(א) במעקב בלבד, בלא טיפול ועם רמת גורמי קרישה גדולה מ-30%	
10%	(ב) עם רמת גורמי קרישה בין 6% ל-30% ועם צורך בטיפולים ייעודיים בשל חבלה או ניתוח	
50%	(ג) עם רמת גורמי קרישה בין 1% ל-5% וצורך בשני טיפולים ייעודיים בשבוע	
75%	(ד) עם רמת גורמי קרישה בין 1% ל-5% וצורך בשלושה טיפולים ייעודיים או יותר בשבוע	
100%	(ה) עם רמת גורמי קרישה מתחת ל-1% וכן צורך בטיפולים ייעודיים תכופים או התפתחות נוגדנים לגורם קרישה	
	במצבי המופיליה עם פגיעה במפרקים עקב דימום חוזר ייקבעו אחוזי נכות נוספים עקב בעיית המפרקים	
	(ז) בחסר מספר של גורמי קרישה, תיקבע הנכות לפי המצב החמור יותר	
	הפרעות המטולוגיות המתבטאות בדימומים (למעט המופיליה)	(18)
0%	(א) בלא הפרעה תפקודית, בלא דימומים חריגים ובלא צורך בטיפול	
10%	(ב) עם הפרעה תפקודית קלה או צורך בטיפולים חוזרים וכן עם דימומים מריריות או בעת מחזור הווסת	
30%	(ג) עם הפרעה תפקודית בינונית ודימום בודד בשנה שהצריך טיפול ייעודי	
50%	(ד) עם הפרעה תפקודית קשה ומספר אירועים של דימום שהצריכו טיפול ייעודי	
100%	(ה) עם הפרעה תפקודית קשה ואירוע דימומי עיקרי או טיפול בעירוי דם (יותר משתי מנות דם);	
	"אירוע דימומי עיקרי" - דימום מסכן חיים, דימום תוך מוחי, דימום מסכן איבר חיוני.	
	תרומבופיליה תורשתית או נרכשת	(19)
0%	(א) בלא טיפול בנוגדי קרישה	
10%	(ב) עם טיפול בנוגדי קרישה	

2א. כשל חיסוני נרכש⁷⁹

0%	(1) בלא סימנים קליניים, בלא טיפול
30%	(2) בלא סימנים קליניים, עם טיפול
50%	(3) עם סימנים קליניים קלים
70%	(4) עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים
100%	(5) עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה

3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה).

הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד)

0%	(א) בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה.
10%	(ב) מצב כמותואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה.
20%	(ג) המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול.
40%	(ד) קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת.
50%	(ה) קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת.
75%	(ו) המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד
100%	(ז) המצב חמור מאוד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד

⁷⁹ פרט 2א - נוסף בק"ת 6675, התשס"ח, עמ' 914, בנוסח דלעיל.

הוראת תחילה, תחולה והוראות מעבר קובעת:

"(א) תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פירסומן (להלן - יום התחילה), והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים ביום התחילה ולאחריו.

(ב) על אף הוראות תקנה 3 בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א 2000, תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש, לגבי מי שנקבע לו שיעור נכות רפואית לפי תקנות אלה, יכול שתקדים בשישה חודשים לכל היותר את ה-1 בחודש שבו הגיש הנכה את הבקשה לבדיקה מחדש, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה בתוך 6 חודשים מיום התחילה.

(ג) על אף הוראות תקנה 36(א) לתקנות העיקריות, רשאי נפגע בעבודה לבקש כי דרגת נכותו תיקבע מחדש לפי תקנות אלה, אף אם טרם חלפו שישה חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו ואף אם לא חלה החמרה בפגימה שבקשר אליה מוגשת הבקשה, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה בתוך שישה חודשים מיום התחילה".

בפרט זה, "אברי המטרה" - עיניים, מערכת העצבים, כליות וכלי דם גדולים וקטנים (כולל מערכת קרדיו וסקולרית).

(א)	היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי	**0%
(ב)	סוכרת בטיפול פומי או אנלוג GLP-1	**10%
(ג)	סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין	20%

⁸⁰ . בק"ת 7405, התשע"ד, עמ' 1586, ת"ת 1.12.14 הוחלף פרט 4 לנוסח הני"ל.

הוראות תחולה קובעות כי הנוסח יחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לערעורים מיום 1.12.14 (להלן - יום התחילה) ולאחריו. עוד נקבע כי על אף האמור לעיל - במהלך 36 החודשים שלאחר יום התחילה, תקבע ועדה או ועדה לערעורים, לפי הענין, את דרגת נכותו של אדם שהגיש את תביעתו לפני יום התחילה, על פי הגבוה מבין אלה: (1) דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות בנוסחן ערב יום התחילה; (2) דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות כתיקון בתקנה 1 לתקנות אלה.

ערב התיקון הני"ל, היה נוסח פרט 4 (כפי שפורסם בק"ת 5856, התשנ"ח, עמ' 2, ת"ת 12.10.97), כדלקמן:

4. סכרת DIABETES MELLITUS		
0%	(1) הפרעה בסבילות לפחמימות IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE	
5%	(2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד.	
10%	(3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים	
20%	(4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין	
40%	(5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי ב. סוכרת "שבירה" (BRITTLE) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד	
40%	(6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול): א. נזירותיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית); ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR); ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית; ד. מחלת כלי דם היקפיים ה. מחלת כלי דם כלילים.	
65%	לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה על 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים	
100%	(7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה	

פרט 4(2) - הניפוי לענין נכות כללית נוסף בק"ת 5994, התשנ"ט, עמ' 1116, ת"ת 10.9.97.
הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לערעורים דנה בענינו לאחר יום התחילה.
פרט 4 - בנוסח מקורי:

(א)	"הסוכר בדם מוגבר במידה קלה עד (160 MG% בצום), אין הפרשת סוכר בשתן או הפרשה קלה (שאינה עולה על 15 GR ביממה) מצב תזונתי טוב, אין סיבוכים, זקוק רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות	***10%****
(ב)	המצב כמתואר לעיל, אבל החולה זקוק לשם איזון לתרופות אנטידיאבטיות בצורת כדורים או כמות INSULIN שאינה עולה על 20 יחידות ליממה	**20%
(ג)	החולה זקוק לכמות INSULIN בינונית, כלומר עד 50 יחידות ליממה, קיימת הפרשת סוכר בשתן שאינה עולה על 30 GR ביממה, אין אצידוזיס, אין הופעות היפוגליקמיות, המצב הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחרים	30%
(ד)	המצב כמתואר לעיל, אבל מופיעים לעיתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי אצידוזיס חולפים ומצב תזונתי ירוד	40%
(ה)	החולה זקוק לכמות INSULIN עד 100 יחידות ביממה, קיימים לפעמים סימנים להיפוגליקמיות או הופעות אצידוזיס חולפות, מופיעים סיבוכים קלים מזמן לזמן כגון: זיהומים, גרדת בעור, ירידה במשקל, פגיעה קלה במערכת העצבים וכו'	50%
(ו)	סכרת קשה הדורשת מעל ל-100 יחידות INSULIN ביממה, מלווה מזמן לזמן בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים (JUVENILE BIRTLE DIABETES)	70%
(ז)	סכרת קשה מאד, הדורשת אשפוז לעתים קרובות או אשר הביאה לסיבוכים קשים, השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה	100%
(ח)	הופיעו סיבוכים כגון: שינויים ברשתית, הפרעות במחזור הדם, פגיעה בכליות, במערכת העצבים וכדומה, במידה שאחוזי הנכות שנקבעו עבור הסכרת לפי הקריטריונים שבסעיפים הקטנים א-1 אינם משקפים סיבוכים אלה, ייקבעו אחוזי נכות נוספים עבור הפגמות בהתאם לאחוזי הנכות לאותה הפגימה."	

- (ד) סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או 40% שימוש במשאבת אינסולין)
- (ה) סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלה: 50% חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או לשני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" - ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל- 50 מ/ג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת מעבדה, והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת
- (ו) סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של 30% לפחות או עם שני סיבוכים לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות 65%
- (ז) סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם 30% לפחות 100%
- (ח) סוכרת הרינית - הנכות בזמן ההיריון תיקבע לפי פרטי משנה (א) עד (ה).
- הערה: לא תיקבע נכות נפרדת בעד ליקוי באברי המטרה שחומרתו 50% או פחות.

5. מחלות ריאה כרוניות⁸¹

לעניין סעיפים 5 ו-6 -

"FEV1" - זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה הראשונה;

"FEV1/FVC" - זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה ראשונה מחולקת בנפח החיוני המאומץ;

"DLCO" - כושר הדיפוזיה;

"VO2 מרבי" - תצרוכת חמצן מרבית מתוך מבחן מאמץ לב ריאה משולב;

81. פרט 5 לחלק א' לתוספת הוסף בנוסח ה"ל בק"ת 8101, התשע"ט, עמ' 704, ת"ת 1.12.18. עוד נקבע בתיקון כי הוא יחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים בתום 90 ימים מיום התחילה ה"ל או לאחריו. הנוסח הקודם היה כדלקמן:

מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות

- (1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (BRONCHIECTASIS)
 - (א) קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים - 0%
 - (ב) קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים - 20%
 - (ג) קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית - 40%
 - (ד) קיימים הממצאים שצוינו בפיסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי דם תכופים - 60%
 - (ה) קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי COR PULMONALE - 100%
- (2) נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה - BRONCHO CUTANEOUS FISTULA OR BRONCHO PLEURAL FISTULA - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.
- (3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה
 - (א) ציסטה קטנה מסויידת - 0%
 - (ב) ציסטה או ציסטות בריאה אחת - 20%
 - (ג) ציסטות בשתי הריאות - 40%
 - (ד) קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.
- (4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות ייקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול
- (5) מחלות ריאה אחרות

במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן (1).
- (6) גוף זר בחלל בית החזה
 - (א) זעיר ואינו גורם להפרעות - 0%
 - (ב) הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלורליות והגבלת תנועות הסרעפת - 10%*
 - (ג) הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוריה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או HEMOPTYSIS - 30%
 - (ד) הגורם ל-TACHYCARDIA וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה-PERI CARDIUM הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה - 50%